国家医疗保障局司便函

关于征求《关于建立新上市化学药品首发价格形成机制 鼓励高质量创新的通知》意见的函

各有关行业协（学）会:

为鼓励以临床价值为导向的药品研发创新，支持高质量创新药品的多元供给和公平可及，完善以市场为主导的药品价格形成机制，国家医保局全面总结新冠治疗药品首发价格形成机制运行经验，经深入调研、多方论证、广泛听取意见，研究起草了《关于建立新上市化学药品首发价格形成机制鼓励高质量创新的通知（征求意见稿）》，并配套拟定《新上市化学药品首发价格分类办理的企业自评量表》和《新上市化学药品首发价格形成指引（试行）》。请你单位积极发挥行业引领作用，组织听取并收集各相关医药企业意见建议。有关意见请于2月26日（星期一）下班前反馈我司医药价格处。文件尚在征求意见阶段，请合理控制阅知范围。感谢对我们工作的大力支持!

传　真：010-89061293

邮　箱：jcs_jzc@nhsa.gov.cn

国家医疗保障局

医药价格和招标采购司

2024年2月5日

关于建立新上市化学药品首发价格形成机制鼓励高质量创新的通知

（征求意见稿）

为进一步落实企业自主制定药品价格政策要求，鼓励以临床价值为导向的药物研发创新，支持高质量创新药品的多元供给和公平可及，充分发挥市场决定性作用，更好发挥政府作用，健全药品价格形成机制，现就新上市化学药品首发价格形成机制有关事项通知如下：

一、坚持药品价格由市场决定的基本原则。除麻醉药品和第一类精神药品外，药品价格依法实行市场调节，由医药企业自主制定。医药企业定价应遵循公平合法、诚实信用、质价相符的法定原则，综合临床治疗价值、生产经营成本、市场供求状况等因素，实事求是确定价格、利润、费用水平。同时主动担当社会责任，努力提升生产经营效率，考虑销售规模对生产经营成本的分摊作用，动态调整价格，实现企业发展、群众受益和社会效果的不断优化。

二、发挥政府对新上市药品价格的支持指引作用。医保部门着力为医药企业自主制定新上市药品价格提供支持指引，建立以信息披露为核心、企业自评和社会监督为支撑的首发上市自主定价制度，通过分层次、有差别的价格措施，整体提升创新药品挂网效率，加快创新成果临床转化，支持

高质量创新药品在产品生命周期起始阶段获得与高投入、高风险相符的收益回报。做好事前事中事后监督，促使医药企业公开透明合理行使自主定价权，不以虚增原料、研发、推广等方式人为虚构投入成本、制定不公平高价，切实维护公众利益。支持有临床价值的高质量创新，价格、挂网、采购等政策资源向真创新、高水平创新倾斜，避免伪创新、低水平“创新”搭便车，挤占高质量创新空间。

三、试行以自主量化评价为基础的分类办理模式。2024年 月 日起，化学药品首次进入国内医药采购平台销售，首发价格试行以量化评价为基础的分类办理模式。国家医保局统一制定首发价格分类办理的企业自评量表（以下简称“自评量表”，详见附件1），从药学物质基础、临床价值、循证证据强度等维度，对企业评价新上市药品创新质量给予指引。首发价格申报企业对照量表，实事求是做好自评，自评结果公开接受社会监督和同行评议。根据企业自评结果，分别适用稳慎、积极、宽松的办理规则，并梯次递进给予政策支持。对于自评点数高的新上市药品，采取简化申报资料、缩短办理流程、办理结果全国通行、保持自主制定价格稳定等措施（附件2）。对于自评点数低的新上市药品，转入常规管理，将价格支持优先导向更高水平、更优质、更急需、更可靠的医药创新。

四、采取新上市药品首发价格集中受理。新上市化学药品首发价格增加集中受理挂网模式，一次受理、全国通行；

其他药品暂按各地现有政策申报挂网。具备条件的省级医保部门可申请作为首发价格受理单位，可指定（委托）其内设机构、直属机构或医药集采机构具体承办（产生首发价格受理单位的具体规则另行制定）。企业自愿选择集中受理模式的，可自主选择1家首发价格受理单位进行申报，应回避申报药品上市许可持有人注册地、药品生产地所在省份，避免连续选择同一受理单位申报价格，或一个年度内多次选择同一受理单位申报价格。受理单位办理涉及重大公共卫生事件、重大公共利益的新上市药品首发价格，以及新上市的麻醉和第一类精神药品首发价格，应同时向国家医保局报告。

五、规范药品首发价格的信息披露工作。信息披露是维护公众知情权和利益的重要保障，也是企业行使自主定价权和政策给予不同程度支持的依据。申报企业按要求提交首发价格相关资料，并承诺对所提交资料的真实性、准确性、有效性负责。主要包括：企业自评量表及支持各项自评主张的书证，首发价格具体构成、测算方法和经济性分析，临床专业意见书和行业协（学）会推荐书，价格展望和守信承诺，药品说明书和审评报告。自评点数高的新上市药品，首发价格具体构成原则上不作资料要求。

六、分类实施药品首发价格的经济性要求。自评点数高的新上市药品，申报企业可自行把握首发价格经济性，不作具体资料要求。自评点数居中的新上市药品，首发价格的疗程费用与对照药品差距保持合理范围，倡导大致相当。自评

点数低的新上市药品，除疗程费用外，首发价格需满足以下经济性要求：不高于同产品主要国家平均价格；与自评量表“药学部分”同一评价项下已上市药品价格大致相当；符合差价比价关系的相关规则；符合当地挂网政策中涉及价格比较、价格联动等规则。

七、引入社会共治和集体评议强化公允性。充分发挥临床专业判断作用，由符合条件的医疗机构出具临床专业意见，从治疗价值、临床需求、采购价格意向等方面对申报药品给出意见。充分发挥行业协（学）会指导、自律作用，由符合条件的行业协（学）会出具推荐书，对首发价格具体构成及特别说明、经济性分析等是否符合行业公允性给出推荐意见。各首发价格受理单位组建药品价格专家组，邀请药学、临床、药物经济、医保价格等方面专家参加，为申报材料的形式审核等提供咨询和专业技术支持。对于申报材料存在重大异议的，该首发价格受理单位牵头组织集体评议，邀请其他首发价格受理单位参与，协调形成办理意见。

八、加快药品首发价格的受理发布进度。自评点数高和居中的新上市药品，自接到国家药监局药品审评中心正式出具的上市许可申请《受理通知书》之日起，企业即可申报首发价格。受理单位提前接收办理，申报资料符合要求的可快速进入公示环节，待国家药监局批准上市后挂网，公示期间有异议的可适当容错放行，加快进入市场；确需调查的，查证后再追溯处理。自评点数低的新上市药品，首发价格待国

家药监局批准上市后申报；符合本通知第五条、第六条要求，同时符合当地药品挂网政策或竞价要求的，进入公示环节，公示有异议的待异议解决后挂网。

九、实行新上市药品的价格风险分类提示。受理单位按照申报资料完整性、首发价格的经济性和公允性等因素，分A、B、C三类提示价格风险，并配套相应的省域间协同挂网、价格风险标识等措施，引导申报企业规范执行新上市药品首发价格指引，自主定价。其中首发价格风险提示为A类的，各地平台对其名称字体或背景作相应标识，引导医疗机构优先选择；首发价格风险提示为C类的，各地平台对其名称字体或背景作相应标识，并以弹窗等醒目方式向医疗机构提示相应风险。自评点数高和居中的新上市化学药品原则上不进入C类。鼓励企业在药品挂网销售后持续改进价格行为、管控价格风险，符合条件的可向首发价格受理单位申报优化价格风险提示类别。新上市药品未选择首发价格集中受理模式的，价格风险提示为B类或C类。

十、建立首发价格省域间协同快速挂网的工作机制。首发价格确定挂网的同时，受理单位应及时将办理结果通报其他省份医保部门，作为其他省份药品集采平台挂网的参考。其中，自评点数高的新上市药品，各地按照首发价格直接挂网，无需企业重复申报。自评点数居中的新上市药品，企业后续在其他省份申报挂网时，报价不高于首发价格的，开辟绿色通道直接挂网，因省域间回款条件、采购数量、配送成

本等客观条件差异，可接受报价以首发价格为基础适当浮动。自评点数低的新上市药品，企业后续在其他省份申报挂网时，应遵循所在省份的挂网规则，鼓励采取竞争性挂网机制，报价高于首发价格将被暂缓受理。

十一、集中受理形成的高质量首发价格设置稳定期。自评点数高和居中的新上市药品，按照批准状态（正式批准、附条件批准）赋予首发价格1-5年不等的稳定期。稳定期内，医疗保障部门和医药采购平台对首发价格执行情况以监测为主，暂不纳入集中带量采购范围，原则上不采取价格约束措施；医药企业主动降价或因医保目录准入等原因形成新的价格，或因严重、特别严重的价格失信行为按规定必须剔除虚高价格空间等情形除外。自评点数低的新上市药品，实行常态化管理，保持省域间挂网价格协同联动、透明均衡。新上市药品未选择首发价格集中受理模式的，不设置价格稳定期。

十二、做实首发价格的再评估和动态调整。稳定期满前3个月内，除已经谈判纳入医保药品目录的情况外，申报企业需向首发价格受理单位提交再评估报告，主要包括：价格运行情况，如各省平台挂网价格，民营医疗机构、社会零售药店、网络药店销售价格，主要国家价格，全国累计销售数量等信息；稳定期满后的降价计划，对照首发报价测算方法、价格构成、经济性分析等所采用参数的实际变化，结合可比市场、可比品种的销售价格，提出稳定期满后降低挂网价格

的考虑，原则上降幅不小于15%，符合规定情形的，需进一步追加降幅。申报企业未按要求进行再评估的，由首发价格受理单位及时函询约谈、督促指导。再评估和动态调整结果参照首发价格做好省域间协同。

十三、强化首发价格形成机制运行的监督指导。国家医保局定期汇总各地办理首发价格、督促再评估和动态调整、落实省域间协同等情况；指导受理单位对不规范、不适宜的首发价格及时调查约谈，必要时进行整改；根据机制运行实际，组织实施首发价格受理单位评估和轮换；对申报企业提供虚假信息、以欺诈手段误导价格、不履行价格承诺等失信行为，指导相关省份落实信用评价和约束措施。指导各地对于首发价格机制参与程度高、创新水平更可靠的医药企业，在药品价格治理、集中带量采购综合评分规则等方面给予支持。

本通知自2024年 月 日起生效。

附件：1.新上市化学药品首发价格分类办理的企业自评量表

2.新上市化学药品首发价格形成指引（试行）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件1

新上市化学药品首发价格分类办理的企业自评量表

药品通用名	剂型	申报首发价格（元）
药品商品名	主规格	计价单位（盒、瓶等）

药品创新程度自评指标	计点规则	企业自评
1. 药学部分	药学点数	
1.1 新机制/新靶点	50点（全球新+10点）	
1.2 新的先导化合物	40点（全球新+10点）	
1.3 现有药物的新衍生物或异构体		
1.3.1 新官能团与母核以不可水解的化学键连接（属于前药的按前药处理）	30点（同类情形已有药品上市，每多1个减1点）	
1.3.2 新官能团与母核以易水解化学键连接，包括但不限于与酸碱构成新的盐或酯	5点（同类情形已有药品上市，每多1个减1点）	
1.3.3 现有药物的同位素取代产物，包括但不限于氘代等	5点（同类情形已有药品上市，每多1个减1点）	
1.3.4 现有药物的新光学异构体	5点（同类情形已有药品上市，每多1个减1点）	
1.3.5 现有药物的前体药物，或者现有药物是其前体药物的	5点（同类情形已有药品上市，每多1个减1点）	
1.3.6 现有药物的新结晶，包括但不限于新晶型、新的结晶水数量	0点	
1.4 新的给药方式		
1.4.1 现有药物的新剂型		
1.4.1.1 涉及给药途径突破性改变	30点	
1.4.1.2 涉及给药途径一般性改变	10点	
1.4.1.3 未涉及给药途径改变，释放方式重大改变（控释、靶向、长效等）	20点	
1.4.1.4 未涉及给药途径改变，释放方式未涉及重大改变	5点	
1.4.2 同一剂型的新规格	0点	
1.4.3 同一药品的新包装（指具有重要的特定临床或药学功能的新包装形式）	10点（单纯外观、材质改变的不计点）	
1.5 新的适应症		
1.5.1 与现有适应症属于不同治疗领域	15点	
1.5.2 与现有适应症属于同一治疗领域	5点	
1.6 新复方制剂		
1.6.1 组分之一属于1.1、1.2、1.3.1中的任意一种的情形，按对应的最高项计分		
1.6.2 各组分均不存在1.1、1.2、1.3.1中的任意一种情形	5点	
2. 临床价值部分	临床价值点数	
2.1 突破性治疗		
2.1.1防治手段从无到有（含防治手段效果从“缓解/维持”到“彻底治愈”的情况）	25点	
2.1.2防治手段从有到优	5点	
2.2 优先审评审批并属于以下任一条件的		
2.2.1 纳入《罕见病目录》的罕见病治疗药	15点	
2.2.2 纳入国家短缺和易短缺药品清单的临床急需短缺药	10点	
2.2.3 甲类和乙类传染病的防治用药	10点（大流行期间紧急上市计15点）	
2.2.4 其他	5点	
2.3 属于国家级政策支持研发和仿制范围并属于以下任一条件的		
2.3.1 属于国家“重大新药创制科技重大专项”	10点	
2.3.2 属于《鼓励仿制药品目录》	5点	
2.4 用于儿童治疗的剂型、规格	儿童专用+10点，儿童兼用+5点	
3. 循证证据部分	循证证据点数	
3.1 临床试验（指关键性注册研究，下同）验证内容		
3.1.1 优效设计	10点	
3.1.2 等效设计	8点	
3.1.3 非劣效设计	5点	
3.2 临床试验方案设计		
3.2.1 随机对照试验	10点（完全接受境外数据-5点）	
3.2.2 非随机对照试验	8点（完全接受境外数据-5点）	
3.2.3 单臂试验	5点（完全接受境外数据-5点）	
3.3 临床试验重现性	每开展1项随机对照试验+4点，最高计10点	
	企业自评点数：	

研发部门负责人：_____（签名）_____

首发报价企业：_____（加盖公章）_____

企业自评时间：_____（年/月/日）_____

计点说明

一、企业申报首发价格前，需要首先对照量表进行自评。自评结果作为受理单位分类办理的直接依据，且在首发价格公示环节作为公示内容接受社会监督和同行评议。自评量表共3部分13组34个评价项，申报药品按自评规则计点，最高可获得的点数为150点（60+60+30）。

二、自评量表“药学部分”，申报药品同时符合多个评价项的，按最高项计点不重复不累计。该部分最高可获得的点数为60点。

三、自评量表“临床价值部分”，按照“突破性治疗”“优先审评审批”“国家级政策支持”“儿童用药”分为4组，各组分别计点并累计；组内按最高项计点不重复不累计。该部分最高可获得的点数为60点（25+15+10+10）。

四、自评量表“循证证据部分”，按照临床试验的“验证内容”“方案设计”“重现性”分为3组，各组分别计点并累计；组内按最高项计点不重复不累计。申报药品同时完成了多项临床试验的，评价项3.1和3.2由企业自行选择循证证据强度最高的1项临床试验进行自评计点。该部分最高可获得的点数为30点（10+10+10）。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件 2

新上市化学药品首发价格形成指引（试行）

（征求意见稿）

为落实以临床价值为导向、信息披露为核心、企业自评和社会监督为支撑的首发价格分类办理机制，将价格政策支持优先导向更高水平、更优质、更急需、更可靠的医药高质量创新，制定本指引，现阶段对化学药品试用。

第一章 分类办理

国家医保局统一制定“药品首发价格分类办理的企业自评量表”量表共 3 部分 13 组 34 个评价项，由国家医疗保障局负责解释。企业申报首发价格前，需要首先对照量表进行自评。自评结果作为受理单位分类办理的直接依据，且在首发价格公示环节作为公示内容接受社会监督和同行评议。

1.1 计点规则

1.1.1 所申报药品的各项特征与对应评价项一致的，按计点规则所列点数计点。

1.1.2 自评量表“药学部分”，申报药品同时符合多个评价项的，按最高项计点不重复不累计。该部分最高可获得的点数为 60 点。

1.1.3 自评量表“临床价值部分”，按照“突破性治疗”“优先审评审批”“国家级政策支持”“儿童用药”分为 4 组，各组分别计点并累计；组内按最高项计点不重复不累计。该部分最高可获得的点数为 60 点（25+15+10+10）。

1.1.4 自评量表“循证证据部分”，按照临床试验（指作为药品审评审批依据的关键临床试验，下同）的“验证内容”“方案设计”“重现性”分为 3 组，各组分别计点并累计；组内按最高项计点不重复不累计。该部分最高可获得的点数为 30 点（10+10+10）。其中，申报药品同时完成了多项临床试验的，评价项 3.1 和 3.2 由企业自行选择循证证据强度最高的 1 项临床试验进行自评计点。

1.1.5“企业自评点数”=药学点数+临床价值点数+循证证据点数，最高可获得的点数为 150 点（60+60+30）。

1.2 自评结果分类

1.2.1 企业自评点数∈[90，150]，属于自评点数高的一档，适用宽松的市场调节价政策，最大限度给予支持。

1.2.2 企业自评点数∈[50，90），属于自评点数居中的一档，适用积极的市场调节价政策，接受企业自主定价结果的同时，关注首发价格的透明度和公允性。

1.2.3 企业自评点数∈[0，50），属于自评点数低的一档，适用稳慎的市场调节价政策，引导企业降低偏高的价格预期。

1.3 其他要求

1.3.1 新上市药品属于麻醉药品或第一类精神药品，且与

已上市品种无差价比价关系的，按照政府定价的相关规则，试销阶段暂由企业按照本指引形成首发价格；与已上市品种存在差价比价关系，企业按不高于差比价规则计算结果的价格报国家医保局备案，各地药品集中采购机构接受企业按照备案价格申报挂网。

1.3.2 自评点数居中的药品，涉及重大公共卫生事件、重大公共利益的，临床需求急迫且具有全国性影响的，必要时可在国家医保局指导下，提档参照自评点数高的药品加快办理首发价格。

1.3.3 企业应实事求是做好自评，公示阶段被发现采取虚假材料、虚假描述等各种方式拔高或压低自评点数的，视为企业的医药价格和招采失信行为，受理单位可按照企业自评结果降一档办理首发价格申报并视情况予以公布。

第二章 申报资料

申报企业按要求提交首发价格资料，并对所提交资料的真实性、准确性、有效性负责。医保部门尊重和信任申报企业自主制定的首发价格。

2.1 自评点数高的药品，申报首发价格提交的资料

2.1.1 药品首发价格分类办理的企业自评量表。首发报价企业盖章以及研发部门负责人签字后生效。提交自评量表需附支持各项自评主张的书证，例如企业主张申报药品符合自

评量表“优效试验”计 20 点的，需要附药品公开审评报告的相关页，并将自评项相应的字段以醒目方式作标记。自评量表所附书证需对应评价项的次序排列。

2.1.2 首发价格经济性分析报告。自评点数高的新上市药品，申报企业可自行把握首发价格经济性，不作具体资料要求。

2.1.3 临床专业意见书。需要至少 1 家医疗机构出具的临床专业意见书，从治疗价值、临床需求、采购价格意向、自评内容是否客观准确等方面对申报药品给出推荐意见。所称医疗机构，是指临床药学或申报药品的相关临床专科中，任一专科列入国家级临床重点专科或 2 个专科列入省级临床重点专科或国家医疗中心的三级甲等公立医疗机构。临床专业意见书经上述医疗机构盖章、相关专科主要负责人签名后有效。

2.1.4 行业协（学）会推荐书。需要至少 1 家行业协（学）会出具的推荐书，对自评内容是否客观准确、首发价格具体构成及特别说明、经济性分析等是否符合行业公允性给出推荐意见。所称行业协（学）会，是指医药类的全国性行业协（学）会，包括综合类的全国性行业协（学）会下设的医药类分会、专委会等内设机构和分支机构。临床专业意见书经上述机构盖章后有效。

2.1.5 首发价格守信承诺。主要内容包括但不限于：承诺对所提交资料的真实性、准确性、有效性负责；承诺首发价

格不包含给予回扣或其他不正当利益的空间，不利用药品垄断地位或市场支配地位操纵价格、牟取不正当利益等；承诺首发价格稳定期间发生严重失信行为、证实存在虚高空间的，及时主动纠正不公平高价；承诺首发价格稳定期满，主动做好再评价和动态调整。

2.1.6 药品说明书和药品审评报告。其中，药品说明书直接提供随药品最小零售包装的正本；药品审评报告提供国家药监局药品审评中心公开发布的版本或国家药监局药品审评中心反馈申报企业的版本。

2.2 自评点数居中的药品，申报首发价格提交的资料

2.2.1 药品首发价格分类办理的企业自评量表。要求同2.1.1。

2.2.2 药品首发价格具体构成及特别说明。药品首发价格构成包括出厂环节的生产制造成本、期间费用、销售利润、税费，以及流通环节差价等5个部分，按要求提供（境外生产进口到我国境内销售，提交进口到岸价、口岸地费用和税费），并就以下事项分别作附页说明，其中加注为“无条件提交”的资料属于附页说明中必需包含的内容，加注为“按条件提交”的资料属于触发相应条件时，附页说明中必需包含的内容：

2.2.2.1（无条件提交）各子项的测算过程，具体到公式和参数。其中，分摊测算所需要的销售数量等参数，尚无实际发生数可引用的，由申报企业根据申报药品的使用方式、

市场潜在需求、同类药品市场表现等自行预估。

2.2.2.2（无条件提交）对原料药成本作特别说明。申报企业自产原料药的，应提供原料药生产成本的具体构成、测算方法，以及相似结构化合物的行业询价结果。申报企业外购原料药的，应提供原料药生产企业出售原料药的合同和发票复印件。进口药品提供到岸价的海关报关单复印件。

2.2.2.3（无条件提交）对直接研发成本作特别说明。包括产生研发成本的具体科目、费用水平、相关书证，以及研发费用分摊计入首发价格的测算方法。直接研发成本的分摊年限原则上不低于5年。

2.2.2.4（按条件提交）对首发报价的费用率作特别说明。首发报价中销售费用率或期间费用率比科创板上市医药企业最近三年平均水平高出10个百分点以上的，申报企业应作出依据充分、逻辑自洽、信息翔实的具体解释；高出15个百分点以上的，申报企业应接受受理单位指导，主动调整报价策略。

2.2.2.5（按条件提交）对首发报价的流通环节差价率作特别说明。首发报价中流通环节差价率[（挂网价格-出厂价）/出厂价格×100%]大于20%的，申报企业应作出依据充分、逻辑自洽、信息翔实的具体解释。

2.2.3 首发价格经济性分析报告。格式和内容要求参照医保目录药品谈判对药物经济学评价的要求。同时应包含首发报价与对照药品的疗程费用比较等内容。具体要求如下：

2.2.3.1 首发报价与对照药品的疗程费用比较。临床试验采取治疗药物或非药物的有效治疗手段作为阳性对照的，经济性分析以阳性对照的疗程费用作为比较对象；临床试验采取安慰剂作对照或未设对照组的，经济性分析以已上市的同类药品中价格处于平均水平的品种作为比较对象；未开展临床试验的，以已上市的同类药品中价格最低的品种（未通过国家药监局仿制药一致性评价的药品、以及集中带量采购中选品种中选价格除外）作为比较对象。

2.2.3.2 首发价格与境外价格比较（由企业自主提供，仅作为内部资料留存）。境外价格指该药品在美国、英国、法国、德国、加拿大、日本、澳大利亚、韩国、印度等国家，以及台湾、香港等地区的同口径销售价格（国际价格以当年1月1日汇率计算，下同），由申报企业据实提供。

2.2.4 临床专业意见书。要求同 2.1.3。出具临床专业意见书的医疗机构数量为 2 家。

2.2.5 行业协（学）会推荐书。要求同 2.1.4。

2.2.6 上市后价格动态调整的展望。即触发以下条件时，企业关于下调挂网价格的规划，具体到价格变动幅度和调价响应时间：

2.2.6.1 稳定期内实际的全国年销售量超过2.2.2.1 预估数量 50%以上，销售费用、研发费用等分摊计算的首发价格构成项已经显著高于实际值。

2.2.6.2 化合物专利到期。

2.2.6.3 从首发价格稳定期开始到结束，经济性分析比较对象的平均挂网价降幅超过 30%（比较对象因医保目录谈判成功、国家或省组织集中带量采购中选引起的降价不列入计算）。

2.2.6.4 正规渠道供应民营医疗机构，或社会零售药店（含网络售药平台）价格低于首发价格。

2.2.6.5 进口药品转本地化生产。

2.2.7 首发价格守信承诺。要求同 2.1.5。

2.2.8 药品说明书和药品审评报告。要求同 2.1.6。

2.3 自评点数低的药品，申报首发价格提交的资料

2.3.1 药品首发价格分类办理的企业自评量表。要求同 2.1.1。

2.3.2 药品首发价格具体构成及特别说明。基本要求同 2.2.2，并就以下事项分别作附页说明：

2.3.2.1（无条件提交）各子项的测算过程，具体到公式和参数。要求同 2.2.2.1。

2.3.2.2（无条件提交）对原料药成本作特别说明。要求同 2.2.2.2。

2.3.2.3（无条件提交）对直接研发成本作特别说明。基本要求同 2.2.2.3。直接研发成本的分摊年限原则上不低于 10 年。

2.3.2.4（按条件提交）对首发报价的费用率作特别说明。首发报价中销售费用率或期间费用率比 A 股上市医药企业

最近三年平均水平高出5个百分点以上的，申报企业应作出依据充分、逻辑自洽、信息翔实的具体解释；高出10个百分点以上的，申报企业应接受受理单位指导，主动调整报价策略。

2.3.2.5（按条件提交）对首发报价的流通环节差价率作特别说明。要求同2.2.2.5。

2.3.3 首发价格经济性分析报告。格式和内容要求参照医保目录药品谈判对药物经济学评价的要求。同时应包含首发报价与对照药品的疗程费用比较、首发价格与境外价格比较等内容。具体要求如下:

2.3.3.1 首发报价与对照药品的疗程费用比较。要求同2.2.3.1。

2.3.3.2 首发价格与境外价格比较。境外价格指该药品在美国、英国、法国、德国、加拿大、日本、澳大利亚、韩国、印度等国家，以及台湾、香港等地区的同口径销售价格，由申报企业据实提供。

2.3.4 临床专业意见书。基本要求同2.1.3。出具临床专业意见书的医疗机构数量为2家。

2.3.5 行业协（学）会推荐书。要求同2.1.4。

2.3.6 上市后价格动态调整的展望。要求同2.2.6。

2.3.7 首发价格守信承诺。主要内容包括但不限于：承诺对所提交资料的真实性、准确性、有效性负责；承诺首发价格不包含给予回扣或其他不正当利益的空间，不利用药品垄

断地位或市场支配地位操纵价格、牟取不正当利益等；承诺接受药品价格常态化监管，发生严重失信行为、证实存在虚高空间的，及时主动纠正不公平高价。

2.3.8 药品说明书和药品审评报告。要求同 2.1.6。

2.3.9 免于提供部分价格资料的情形。自评点数低的药品，同时符合 2.3.9.1 和 2.3.9.2 两项条件的，申报首发价格可以免于提交资料 2.3.2.1-2.3.2.5，以及 2.3.3-2.3.6:

2.3.9.1 申报药品自评的“药学部分”计点项（即药学部分自评点数最高的 1 项），属于“1.3.2-1.3.5”“1.4.2-1.4.3”“1.5.1”任意 1 评价项。

2.3.9.2 申报的首发价格低于所有已上市可比药品按照差价比价规则换算的价格，或者注射剂代表规格首发价格低于每支 5 元及以下、口服固体制剂代表规格首发价格低于每片（粒）0.5 元及以下。

第三章 经济性要求

建议企业自主制定首发价格时，结合自评结果，充分考虑以下经济性要求:

3.1 自评点数高的药品，需要考虑的经济性要求

3.1.1 经济性分析报告。只作资料要求，报告对于首发价格经济性分析，要体现全面性、完整性。首发价格是否具有经济性由申报企业自行把握，原则上不作具体要求。

3.1.2 境外价格比较。原则上不作具体要求。

3.1.3 差价比价关系。申报药品同时上市多个规格的，以Ⅲ期临床试验的用药规格作为代表规格，其他规格首发价格与代表规格应符合差比价规则。

3.2 自评点数居中的药品，需要考虑的经济性要求

3.2.1 对照药品费用比较。

3.2.1.1 临床试验采取治疗药物或非药物的有效治疗手段作为阳性对照的，“申报药品首发价格折算的疗程费用”≤“对照药品最高挂网价格折算的疗程费用/非药物治疗的疗程费用”×（1+K）；K 指申报药品在临床试验主要疗效终点方面相对于阳性对照的改善程度。

例如某肿瘤药关键临床试验以总生存期（OS）为主要疗效终点，结果显示其总生存期 12 个月，对照药品总生存期 9 个月，则：K=（12-9）/9×100%=33%

3.2.1.2 临床试验采取安慰剂作对照或未设对照组的，“申报药品首发价格折算的疗程费用”≤“比较对象评价挂网价格折算的疗程费用”，比较对象同 2.2.3.1，指已上市的同类药品中价格处于平均水平的品种。

3.2.1.3 未在国内开展临床试验的，“申报药品首发价格折算的疗程费用”≤“比较对象评价挂网价格折算的疗程费用”，比较对象同 2.2.3.1，指以已上市的同类药品中价格最低的品种，未通过国家药监局仿制药一致性评价的药品、以及集中带量采购中选品种中选价格除外。

3.2.2 境外价格比较。原则上不作具体要求，由企业自主选择提供。

3.2.3 差价比价关系。申报药品首发价格符合差比价规则的各项规定。其中，申报药品同时上市多个规格的，以Ⅲ期临床试验的用药规格作为代表规格，未开展Ⅲ期临床试验的以拟上市的最小规格作为代表规格，其他规格首发价格与代表规格之间符合差比价规则。申报药品已有相同上市许可持有人生产或委托生产的同种药品其他规格销售，首发价格与在售规格之间符合差比价规则。

存在差比价规则规定例外情形的，可以单独作为该类型的代表规格，同时附相关书证。

3.2.4 其他。申报药品首发价格未超过“临床专业意见书”的采购意向价格的 130%。

3.3 自评点数低的新上市药品，需要考虑的经济性要求

3.3.1 对照药品费用比较。

3.3.1.1 以自评量表“药学部分”同一评价项下已上市药品价格为对照，首发价格未超过已上市药品价格的（1+自评点数百分数）的平方。

例如新上市药品企业自评点数为 40，自评量表“药学部分”同一评价项下已上市药品价格为 10 元，首发价格未超过 $10\times(1+40\%)^2=19.6$ 元的可以认为具有一定的经济性。如企业自评点数为 10，则首发价格未超过 $10\times(1+10\%)^2=12.1$ 元的可以认为具有一定的经济性。

3.3.1.2 未超过专利期价格的 70%。

3.3.2 境外价格比较。

3.3.2.1 原产国上市时间未超过 3 年的，首发价格不高于美国同口径销售价格;

3.3.2.2 原产国上市时间超过 3 年，未超过 5 年的，首发价格不高于英国、法国、德国、加拿大、日本、韩国、澳大利亚等国家的中位价格，或不高于美国同口径销售价格的 70%;

3.3.2.3 原产国上市时间超过 5 年的，首发价格不高于台湾、香港地区同口径销售价格，或不高于英国、法国、德国、加拿大、日本、韩国、澳大利亚等国家的最低价格，或不高于美国同口径销售价格的 60%。

3.3.3 差价比价关系。具体要求同 3.2.3。

3.3.4 其他。

3.3.4.1 符合受理单位当地挂网政策中涉及价格比较、价格联动的各项规则。

3.3.4.2 申报药品首发价格不高于“临床专业意见书”的采购意向价格。按照 2.3.9 免资料的情形不作此项要求。

第四章 受理和发布

新上市药品首发价格的受理和发布，由受理单位按照企业自评结果分类办理，促进高质量的创新药品加快进入临床

应用。

4.1 自评点数高的药品，受理和发布首发价格的要求

4.1.1 提前介入。自接到国家药监局药品审评中心正式出具的上市许可申请《受理通知书》之日起，企业即可向符合条件的受理单位申报首发价格。受理单位提前介入，指导企业完善资料，协助企业提前申请医保编码，做好公示和挂网准备。

4.1.2 快速公示。申报药品获得国家药监局注册批件后，受理单位应尽快通过官方渠道公示首发价格，具备条件的尽可能在获得注册批件的当天或者次日公示，公示时间为 7 个自然日。公示内容包括药品通用名称、商品名称、剂型规格、首发价格、风险提示信息，同时将申报资料中的“药品首发价格分类办理的企业自评量表”“临床专业意见书”“行业协（学）会推荐书”“首发价格守信承诺”作为附件一并公示。

4.1.3 异议容错。公示期间出现异议的，受理单位原则上只受理与本指引要求相关的异议，并且可以根据情况容错处理，必要时通知申报企业对异议内容进行解释说明。

4.1.3.1 异议内容不涉及企业自评结果的，异议是否解决不影响公示结束后按首发价格挂网销售。后续处理结果显示异议成立的，可以根据实际情况，通过实施医药价格和招采信用评价、督促纠正不公平高价、暂停或中止挂网采购资格等方式进行追溯处理。

4.1.3.2 异议内容针对企业自评结果，且可能导致自评分

档发生变化的，需要在异议解决后再进入挂网环节。其中，异议成立但不影响自评点数分档的，或者异议不成立的，重新履行公示程序，仅限一轮。异议成立且自评点数下降一档的，申报企业需要按实际分档重新履行首发价格申报程序。申报企业拒绝回应异议的，参照“异议成立且自评点数下降一档的”的情况处理。

4.1.4 结果发布。

经公示具备挂网条件的，公示期满后的第 1 个工作日在首发价格受理省份的药品集中采购平台正式挂网，接受医疗机构采购。受理单位应在正式的首发价格挂网同时，将办理结果通报其他省份医保部门，作为其他省份药品集采平台挂网的参考。通报内容包括但不限于药品基本信息、首发价格、价格稳定期起止时间（具体到年月日）、自评结果（可直接附申报企业提交的自评量表复印件）等。

经公示不具备挂网条件的，受理单位公示期满后将终止办理的结果以及重新申报的建议函告申报企业，同步抄送其他省份的受理单位。

4.1.5 省域间协同挂网。自评点数高的药品采取自动挂网，各省医保部门指导督促本省药品集采平台按照通报的预首发价格直接预挂网，无需企业自行前往重复申报相关资料，企业明确配送企业和供应信息后即自动挂网，不以本地挂网程序、资料要求为由拒绝或推迟挂网。

4.2 自评点数居中的药品，受理和发布首发价格的要求

4.2.1 提前介入。基本要求同 4.1.1。其中，受理单位同时接受多个新上市药品首发价格申报、超出承受能力的，自评点数高的药品优先办理。

4.2.2 价格公示。基本要求同 4.1.2。公示资料增加首发价格具体构成以及经济性分析的主要结论等 2 项内容。公示时间为 7 个自然日。

4.2.3 异议处理。公示期间出现异议的，受理单位原则上只受理与本指引要求相关的异议，并及时通知申报企业对异议内容进行解释说明。

4.2.3.1 异议内容针对企业自评结果，且可能导致自评分档发生变化的，处理要求同 4.1.3.2。

4.2.3.2 异议内容针对企业价格构成或者经济性分析结论的，受理单位关注申报资料是否符合第二章、第三章相关要求即可，不符合的需要申报企业进行补充说明，必要时下调不具有经济性的首发价格。

4.2.3.3 其他异议内容不影响公示结束后按首发价格挂网销售，后续处理结果显示异议成立的，参照 4.1.3.1 追溯处理。

4.2.4 结果发布。要求同 4.1.4。

4.2.5 省域间协同挂网。自评点数居中的药品采取企业申报挂网，各省医保部门指导督促本省药品集采平台参考通报的首发价格配合企业做好挂网工作。其中，企业申报挂网价格不高于首发价格的，开辟绿色通道随时直接挂网，不以本地挂网程序、资料要求等为由拒绝或推迟挂网；企业因省域

间回款条件、采购数量、配送成本等客观条件差异，以首发价格为基础适当上浮未超过5%的水平申报挂网的，接受企业申报价格，按照常规程序集中发布。

4.3 自评点数低的药品，受理和发布首发价格的要求

4.3.1 不提前介入。申报药品获得国家药监局注册批件后，企业再向符合条件的受理单位申报首发价格。受理单位同时接受多个新上市药品首发价格申报、超出承受能力的，优先保证自评点数高和居中的药品首发价格得到及时办理。

4.3.2 价格公示。基本要求同4.1.2。公示资料增加首发价格具体构成以及经济性分析的主要结论等2项内容，按照2.3.9免资料的情形不作此项要求。公示时间为7个自然日，属于短缺和易短缺药品、妇儿和急（抢）救药品的，必要时可以根据临床急需程度缩短公示期。

4.3.3 异议处理。公示期间出现异议的，受理单位原则上只受理与本指引要求相关的异议，并及时通知申报企业对异议内容进行解释说明，必要时下调不具有经济性的首发价格。异议解决后再进入结果发布和挂网环节。

4.3.4 结果发布。

经公示具备挂网条件的，公示期结束后由首发价格受理省份的药品集中采购平台按照本地规定程序挂网，接受医疗机构采购。受理单位应在正式的首发价格挂网同时，将办理结果通报其他省份医保部门，作为其他省份药品集采平台挂网的参考。通报内容包括但不限于药品基本信息、首发价格、

价格稳定期起止时间（具体到年月日）、自评结果（可直接附申报企业提交的自评量表复印件）等。

经公示不具备挂网条件的，受理单位公示期满后将终止办理的结果以及重新申报的建议函告申报企业，同步抄送其他省份的受理单位。

4.3.5 省域间协同挂网。自评点数低的药品采取企业申报挂网，各省份药品集中采购机构按照当地既定规则办理；鼓励采取竞争性挂网的方式，将市场价格导入更具有经济性的区间。

第五章 价格风险提示

受理单位按照新上市药品申报资料完整性、首发价格的经济性和公允性等因素分类提示价格风险，配套相应的省域间协同挂网、价格风险标识、医保临时支付等措施，接受企业挂网后持续优化价格风险提示的类别。

5.1 价格风险分类

5.1.1 自评点数高的药品价格风险分类。对于自评点数高的药品，首发价格风险提示原则上只设 A 类和 B 类。

5.1.1.1 同时符合以下情形的作为 A 类药品：国家药监局常规批准上市；首发价格申报资料完整、充分，符合本指引第二章“申报资料”的各项相关要求；同类药品已正式进入医保药品目录的，按照疗程治疗费用比较，首发价格不高于目

录内同类药品最高挂网价格2倍；公示期间未被投诉举报或挂网前异议已解决（与本指引要求相关的异议，不影响价格风险分类，下同）。

5.1.1.2 首发价格的其他情形均作为B类药品。

5.1.2 自评点数居中的药品价格风险分类。对于自评点数居中的药品，首发价格风险提示设A类、B类和C类。

5.1.2.1 同时符合以下情形的作为A类药品：首发价格申报资料完整、充分，符合本指引第二章“申报资料”的各项相关要求；同类药品已正式进入医保药品目录且数量在3个以内（不含3个，按照医保通用名计）的，按照疗程治疗费用比较，首发价格不高于目录内同类药品最高挂网价格1.8倍；公示期间未被投诉举报或挂网前异议已解决。

5.1.2.2 符合以下情形之一的作为B类药品：

5.1.2.2.1 申报资料基本符合本指引第二章的各项要求，即药品首发价格分类办理的企业自评量表、临床专业意见书、行业协（学）会推荐书、首发价格守信承诺、药品说明书和药品审评报告等5件申报资料完整、充分，但药品首发价格具体构成及特别说明、首发价格经济性分析报告、上市后价格动态调整的展望中的任意1件内容不完整、不充分。其中，“不完整”指2.2.2.1-2.2.2.5，2.2.3.1-2.2.3.2，以及2.2.6.1-2.2.6.5中任意1项未按要求提供。“不充分”是指2.2.2.1-2.2.2.5，2.2.3.1-2.2.3.2，以及2.2.6.1-2.2.6.5中有书证要求的任意1项，申报资料中未提供书证；或者有量化要求的任意1项，申报

资料中未明确量化结果。

5.1.2.2.2 第三章“经济性要求”3.2.1-3.2.4 中任意 1 项不完整、不充分的。其中“不完整”是 3.2.1-3.2.4 任意 1 项未按要求提供。“不充分”是指 3.2.1-3.2.4 中有书证要求的任意 1 项未提供书证；或者有量化要求的任意 1 项，未明确量化结果。

5.1.2.2.3 公示期间被投诉举报，异议需要在挂网后继续处理的。

5.1.2.3 符合以下情形之一的作为 C 类药品：

5.1.2.3.1 申报资料不符合本指引第二章的关键性要求，即药品首发价格分类办理的企业自评量表、首发价格具体构成及特别说明、首发价格经济性分析报告临床专业意见书、行业协（学）会推荐书、首发价格守信承诺、上市后价格动态调整的展望等 6 件申报资料中任意 1 件缺失。

5.1.2.3.2 经济性要求 3.2.1-3.2.4 中任意 2 项或多项不完整、不充分的。不完整、不充分的具体要求同 5.1.2.2.2。

5.1.3 自评点数低的药品价格风险分类。对于自评点数低的药品，首发价格风险提示设 A 类、B 类和 C 类。

5.1.3.1 符合以下情形的作为 A 类药品：属于按照 2.3.9 项免于提供部分价格资料的药品。

5.1.3.2 符合以下情形的作为 B 类药品：不属于 A 类药品和 C 类药品的其他情形。

5.1.3.3 符合以下情形之一的作为 C 类药品：

5.1.3.3.1 第二章“申报资料”要求的任意 1 项存在缺失。

5.1.3.3.2 第三章“经济性要求”3.3.1-3.3.4 中任意 1 项缺失、不完整、或不充分的。

5.1.3.3.3 公示期间被投诉举报且异议未解决的。

5.2 价格风险提示的分类的变更

5.2.1 新上市药品正式挂网销售后，在 1 个及以上省份出现医药价格和招采信用评级“严重”失信或“特别严重”失信，申报企业未采取降价措施将信用评级修复至“严重”失信以下的，受理单位应将价格风险提示分类调整为 C 类并公开通报，其他省份同步下调至 C 类；申报企业采取降价等措施将信用评级修复至“严重”失信以下的，受理单位将本地平台挂网价格下调至相同水平，同时将价格风险提示分类回调至 B 类，并通报其他省份及时协同联动。

5.2.2 支持企业在药品挂网销售后持续改进自身价格行为、补齐价格风险短板，原风险点已经化解的，可以向首发价格受理单位申报优化价格风险提示的类别。其中，自评点数高的药品符合 A 类药品，但因附条件批准/授权紧急使用的作为 B 类药品的，完成确证性研究后也可以向首发价格受理单位申报优化价格风险提示的类别。

5.3 不同价格风险提示类别的挂网要求

5.3.1 A 类药品的挂网要求。各省级医药采购平台将其名称字体或背景显示为绿色，在网页检索结果中靠前展示，引导采购单位优先选择。

5.3.2 B 类药品的挂网要求。各省级医药采购平台将其名称字体或背景显示为黄色。

5.3.3 C 类药品的挂网要求。各省级医药采购平台将其名称字体或背景显示为红色；自评点数低的药品同时属于 C 类药品的，以弹窗等醒目方式向采购单位提示相应风险。受理单位可暂缓挂网，并书面建议企业化解风险点、优化价格风险提示类别后重新申报首发价格；其中对于短缺和易短缺药品，可以按照 4.2.4-4.2.5 挂网，同时执行 5.3.3 关于 C 类药品挂网的一般要求。

第六章 首发价格稳定期与动态调整

为支持创新药品在产品生命周期的起始阶段获得与高投入、高风险相符的收益回报，鼓励有价值、高质量的医药研发，对于新上市药品的首发价格，综合考虑新上市药品自评结果和批准状态，分别赋予 1-5 年不等的稳定期（自批准上市之日起计算），医疗保障部门和集中采购机构对稳定期内的首发价格执行情况以监测为主。

6.1 首发价格稳定期的具体标准

6.1.1 自评点数高的药品：属于国家药监局常规批准的，首发价格稳定期 5 年；属于附条件批准或者授权紧急使用的，稳定期 3 年，稳定期内完成确证性研究或转常规批准的，可顺延至总共 5 年。

6.1.2 自评点数居中的药品：属于国家药监局常规批准的，首发价格稳定期 3 年；属于附条件批准或者授权紧急使用的，稳定期 1 年，稳定期内完成确证性研究或转常规批准的，可顺延至总共 3 年。

6.1.3 自评点数低的药品：不设置首发价格稳定期，自正式的首发价格挂网之日起，即实行常态化管理。

6.1.4 其他。属于麻醉药品和第一类精神药品的，首发价格稳定期 1 年，不按自评点数高低区别设置价格稳定期。

6.2 稳定期保持首发价格基本稳定

稳定期内不纳入集中带量采购范围，不实施政府定价或政府指导价，暂不以当地挂网规则要求降价，不与国外价格作比较；医药企业主动参与医保目录准入谈判等自行降价，或因严重、特别严重的价格失信行为按规定必须剔除虚高价格空间等情形除外。

6.3 稳定期结束后的价格动态调整

6.3.1 首发价格再评估。除已经谈判纳入医保药品目录的情况外，首发价格申报企业在稳定期截至日期的 1 个月前向首发价格受理单位提交再评估报告，报告内容包括但不限于：

6.3.1.1 首发价格运行情况，如各省平台挂网价格，民营医疗机构、社会零售药店、网络药店销售价格，主要国家价格，全国累计销售数量等信息；

6.3.1.2 稳定期满后的调价计划。参照 2.2.6“上市后价格动态调整的展望”所列的各项要求进行陈述，据实提出稳定期

满后的具体调价计划。

6.3.2 稳定期满动态调整。稳定期满后受理单位调整挂网价格，原则上按照申报企业再评估报告中的调价计划下调挂网价格；企业未提供再评估报告或再评估报告未涉及调价计划的，按照首发价格降 15%挂网。

6.3.3 省域间协同联动。受理单位应在稳定期满后第 1 个工作日起下调原首发价格并挂网，同时将办理结果通报其他省份医保部门，作其他省份药品集采平台挂网的参考。其他省份应尽快协同联动降低相关药品在本省份挂网的价格，鼓励采取竞争性挂网、集中带量采购、跨省联盟采购的方式，将相关药品市场价格导入更具有经济性的区间。

第七章 其他支持政策

对于首发价格形成机制参与程度高、创新水平更加可靠的医药企业，鼓励各地从医药价格和招采政策方面给予支持。

7.1 可以采取的支持政策

7.1.1 药品差比价关系。企业选择集中受理模式，新上市药品各剂型规格同时形成首发挂网价格的，企业自主选择代表剂型和代表规格计算差价比价关系，受理单位不以当地挂网规则为由进行干预。

7.1.2 药品采购规则。国家组织药品集中带量采购续约、地方组织的集中带量采购、跨省联盟集中带量采购、竞价挂

网采购中采取综合指标评分的，如涉及企业创新能力评分的，应将首发价格形成机制参与程度、创新水平可靠性作为评分指标。

7.1.3 药品价格和招采信用评价。选择集中受理模式形成首发价格的药品，在企业因医药价格和招采信用评价被采取中止挂网资格等约束措施时，同时符合以下条件的新上市药品可以豁免相应的约束措施：

7.1.3.1 该药品与企业给予回扣、垄断涨价等失信案由无关。

7.1.3.2 该药品属于自评点数高或居中的情况。

7.1.3.3 该药品的价格风险提示属于 A 类或 B 类。

例如，某企业失信等级评定为“特别严重”，根据《医药价格和招采信用评价的操作规范（2020 版）》应限制或中止该企业全部药品和医用耗材挂网、投标或配送资格。若该企业的新上市药品满足以上条件，则该新上市药品可豁免相应的约束措施，仍可按正常程序挂网、投标和配送。

7.2 判断标准

7.2.1 首发价格形成机制参与程度。该企业 2024 年*月后新上市药品品种数为 A，选择集中受理模式形成首发价格的药品品种数为 a，首发价格形成机制参与程度=a/A×100%。

7.2.2 创新水平。该企业 2024 年*月后新上市药品中，选择集中受理模式形成首发价格，自评点数高的药品品种数为 a_1，自评点数居中的药品品种数为 a_2，自评点数低的药品品种数为 a_3，创新水平=[（a_1+1）^{2}+a_2+（a_3-0.5）$^{1/2}$]/A×100%。